

Université 03- faculté de médecine de Constantine
Cours psychologie médicale module sémiologie-Année
universitaire 2024-2025

Psychologie de la douleur
Pr khellaf. A

- Plan :
- Introduction
- Définition
- Physiologie de la douleur et mécanisme
- Les différents types de la douleur
- Les composantes de la douleur
- Facteurs interagissant les uns avec les autres pour générer une expérience douloureuse
- Evaluation du malade douloureux
- La prise en charge
- Conclusion

I-Introduction

- Les modes d'expression de la douleur varient, mais sa présence traduit toujours la volonté de communiquer sa souffrance.
- Le dictionnaire Littré la décrit comme « une souffrance physique ou une souffrance qui est à l'âme ce que la souffrance physique est au cœur ».
- **Adams** et **Rosnik** définissent la douleur comme étant une des premières expériences sensibles qui permettent à l'homme de découvrir en lui l'existence de la maladie et donc comme un signe caractéristique dont l'absence entraîne toujours une incertitude diagnostique.
- La douleur possède donc deux dimensions intimement liées : psychologique et somatique.
- On pourrait par exemple parler de la douleur morale du déprimé comme n'étant que psychologique, ou de la douleur provoquée par une blessure par une arme blanche comme n'étant que somatique.
- Qu'elle soit d'origine psychique ou physique, la douleur constitue un véhicule de communication que le patient nous force à prendre en considération.

II-DEFINITION :

- L'association internationale pour l'étude de la douleur a proposé la définition suivante : « la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréables liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes »
- Ainsi, même si généralement la douleur est secondaire à une cause physique évidente, cette définition souligne également l'intrication étroite existant entre l'organicité d'une douleur et ses conséquences émotionnelles, affectives et sur les réactions individuelles de chaque patient.

III Physiologie de la douleur et mécanisme

- Lorsqu'on se blesse (brûlure, coupure...), la douleur est déclenchée par l'excitation des récepteurs, c'est-à-dire des terminaisons nerveuses spécialisées dans la transmission du message douloureux. Ce message est ensuite transmis au cerveau via les nerfs périphériques, puis la moelle épinière.

IV-LES DIFFERENTS TYPES DE LA DOULEUR

- Il est important de comprendre ce qu'est la douleur afin de mieux la gérer.

Plus précisément, il existe deux types de douleurs:

- la douleur nociceptive ou douleur aiguë, qui dure généralement moins de trois mois, et la douleur chronique, ou récidivante qui persiste au-delà de trois à six mois.

A-Douleur aiguë ou douleur nociceptive

te. Elle se divise en deux sous-

douleur nociplastique.

des lésions situées dans le système
la moelle épinière ou des nerfs elle
suite à une lésion qui a depuis
ionnement du système nerveux lui

douleur aiguë est une douleur vive immédiate, et généralement
ve. Elle est causée par une stimulation nociceptive de l'organisme,

telle une lésion tissulaire, pouvant se produire sous la forme d'un
stimulus thermique (contact de la peau avec du feu) ou mécanique (un
pincement, un coup). « La douleur aiguë joue donc un rôle d'alarme
qui va permettre à l'organisme de réagir et de se protéger face à un
stimulus mécanique, chimique ou thermique. » ; sa fonction d'alerte est
alors justifiée.

B-Douleur chronique

- La douleur chronique est différente. Elle se divise en deux sous-catégories :
 - La douleur neuropathique et la douleur nociplastique.
- 1- La douleur neuropathique due a des lésions situées dans le système nerveux au niveau du cerveau, de la moelle épinière ou des nerfs elle peut survenir suite a une maladie, suite a une lésion qui a depuis disparue ou a cause d'un dysfonctionnement du système nerveux lui même

- Un accident vasculaire cérébral (AVC), une hernie discale, un syndrome du tunnel carpien et le diabète sont des exemples de conditions de santé qui peuvent causer de la douleur neuropathique. Dans ce type de douleur, il y a souvent un signe de lésion du niveau de la fibre nerveuse. Cependant, les sensations douloureuses sont souvent disproportionnées par rapport aux dommages réels, c'est-à-dire que les lésions sont d'une ampleur plus faible que la douleur qu'elles provoquent, qui, elle, peut être très grande.

- la douleur nociplastique: due à un dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur les mécanismes sont encore très mal connus les examens cliniques ne révèlent ni lésions ni atteinte des nerfs c'est La dimension psychologique englobe la réponse affective émotionnelle, cognitive ou comportementale à une agression douloureuse.

- Les douleurs chroniques s'accompagnent de difficultés psychologiques. Progressivement, le désordre physique va provoquer des réactions psychologiques diverses : fatigue, insomnie, anxiété, dépression, désintérêt sexuel. Avec le temps, ces réactions psychologiques constituent un facteur d'exacerbation ; d'entretien de la douleur et on se retrouve devant un mécanisme de cercle vicieux

V) LES COMPOSANTES DE LA DOULEUR

- A/ Composante affective de la douleur
- Cette composante fait partie intégrante de l'expérience douloureuse et peut se prolonger vers des états plus différenciés telles que l'anxiété et la dépression
- B/ Composante cognitive de la douleur
- Désigne l'ensemble des processus intellectuels susceptible d'influencer la perception de la douleur et les réactions qu'elle détermine :
 - -Processus d'attention et de détournement de l'attention.
 - - Interprétation et valeurs attribuées à la douleur, anticipation, références à des expériences douloureuses antérieures personnelles ou observées.
 - - Décisions sur le comportement à adopter.

C/Composante comportementales de la douleur

- La composante comportementale englobe l'ensemble des manifestations verbales et non verbales observables chez la personne qui souffre (plaintes, gémissement, mimique, posture antalgique...).
- Ces manifestations réactionnelles à un stimulus nociceptif assurent une fonction de communication avec l'entourage.
- Ces comportements acquis, sont fonction de l'environnement familial, de la culture,

VI- FACTEURS INTERAGISSANT LES UNS AVEC LES AUTRES POUR GENERER UNE EXPERIENCE DOULOUREUSE :

- Durant de nombreuses années, le modèle de référence était le modèle anatomo-pathologique qui faisait un lien direct entre la pathologie et l'endroit où la douleur elle était ressentie. Par exemple, le mal au dos, une IRM pour trouver une hernie discale ou tout autre cause physique pouvant expliquer la survenue de ce mal de dos. Et si rien n'apparaissait à l'imagerie, alors la douleur ressentie par la personne restait inexpliquée et souvent sous-estimée. Ce modèle se voulait très réducteur.
- En effet, alors que plusieurs personnes présentaient la même anomalie à l'imagerie, ceux-ci ne ressentaient pas la même intensité de douleur, ce qui laissait suggérer que d'autres facteurs contribuaient à la douleur.
- C'est donc à partir de là qu'est apparu le **modèle bio psycho social** permettant de définir tous les **différents facteurs impliqués** dans la **douleur**.

- Ce modèle a été décrit pour la première fois par Engel en 1977. Expliquant parfaitement les **interactions** entre le **biologique**, (l'influence de notre corps), le **psychologique**, (l'influence de notre cerveau) et le **social** (l'influence de notre environnement) dans la **survenue de la douleur**. Cette nouvelle approche a permis de renouveler les conceptions de la relation entre le thérapeute et son patient en s'intéressant non seulement aux **causes biologiques** de la **douleur** mais aussi à l'**environnement** dans lequel vit et évolue le patient, à ses **traits de personnalité**, à son **humeur** ou encore à ses **capacités d'adaptation**

1)facteur biologique

- Si nous prenons l'exemple de l'arthrose, il existe de **nombreux facteurs biologiques** expliquant la survenue d'une arthrose. Nous pouvons donc citer: l'âge, le sexe (risque plus important d'arthrose chez les femmes), la présence d'une inflammation ou encore les changements biomécaniques et physiologiques qui surviennent dans l'articulation atteinte.
- Les récepteurs de la douleur envoient l'information au cerveau qui va décider de déclencher de la douleur ou non.

2)Facteur psychologique

- Stress et anxiété :
 - de nombreuses études montrent que lorsque nous sommes particulièrement stressés ou angoissés, la sensation douloureuse sera perçue de manière plus importante
- Situation de danger :.
 - en situation de **danger**, la douleur peut totalement **disparaître** ,car l'attention du sujet est focalisée sur le danger.
- L'impact qu'ont certaines **croyances** sur nos douleurs : si nous pensons que notre dos est particulièrement fragile et que cette fragilité aura de graves conséquences sur notre corps, notre système d'alarme de la douleur sera plus sensible et donc les douleurs ressenties plus importantes et plus fréquentes.

- le catastrophisme :. C'est le fait d'imaginer sa situation se dégrader de plus en plus et d'avoir des croyances très pessimistes sur sa douleur. Ce processus cognitif émotionnel est associé à la **rumination** et à **l'impuissance** ressentie par la personne face à une expérience douloureuse. Ces personnes sont **plus à risque** de ressentir de la **douleur** et ce sentiment peut être un véritable **obstacle** à la **gestion** de cette **douleur**.
- Le catastrophisme est en lien avec de nombreux autres processus psychosociaux favorisant la douleur comme la **dépression**, l'**anxiété** ou encore la **détresse**
- la kinésiophobie qui est un mécanisme engendrant la **peur du mouvement**. Par exemple, vous vous bloquez le dos en voulant vous relever très vite, il est très probable que la prochaine fois vous aurez quelques appréhensions avant de refaire ce même mouvement. Le cerveau, pensant nous protéger d'un danger, va nous inciter à éviter certains mouvements identifiés comme douloureux. Même si dans un premier temps cela peut s'avérer bénéfique pour éviter de se refaire mal, à plus long terme cela amène à de la peur et donc à un manque de mouvement et de la douleur. C'est un véritable cercle vicieux.

- les expériences traumatisantes vécues dans l'**enfance** qui influencent nos douleurs.

Des études ont montré que les personnes ayant vécu au moins deux événements psychosociaux indésirables, comme par exemple: des violences physiques, des difficultés économiques, un divorce, la perte d'un être cher...courent un plus grand risque de développer une douleur

- Tous ces facteurs sont en lien étroit les uns avec les autres et influencent fortement la perception de la douleur.

3) Facteur social.

- soutenu par ses proches, ses collègues, aura un **impact positif** sur la perception des **douleurs**.
- Le **soutien social** a un **rôle bénéfique** sur les émotions positives, la diminution de la dépression et la **perception de la douleur**.
- études montrent que les facteurs psychologiques et sociaux sont plus impactant sur les douleurs chroniques que les facteurs biologiques

VII-EVALUATION DU MALADE DOULOUREUX

- Les médecins doivent évaluer la cause, la gravité et la nature de la douleur, ainsi que ses effets sur l'activité, l'humeur, la cognition, et le sommeil.
- Le bilan de la cause des douleurs aiguës (p. ex., douleurs rachidiennes, douleurs thoraciques) est différent de celui de la douleur chronique.

- L'anamnèse: doit
 - comprendre les informations suivantes sur la douleur (début, intensité, localisation, irradiation, facteurs aggravants):
 - permet de guider le choix des examens de laboratoire et d'imagerie pour identifier les causes possibles de la douleur
 - Des antécédents personnels ou familiaux de douleur chronique peuvent permettre d'éclairer le problème actuel.
- La sévérité de la douleur doit être évaluée Chez les patients qui expriment verbalement leur douleur,
- l'auto-évaluation est l'indicateur de référence et les signes extérieurs de douleur ou de souffrance (p. ex., pleurs, gémissements, balancement) sont secondaires.
- Chez les patients qui ont des difficultés à s'exprimer verbalement et chez les jeunes enfants, les signes non verbaux (comportementaux et parfois physiologiques) peuvent être la principale source d'information

VIII- PRISE EN CHARGE

- Lors de douleur aiguë, au-delà de la composante sensorielle due à la lésion, la composante affective et émotionnelle doit être prise en compte de façon systématique, d'autant plus si la plainte paraît anormalement élevée
- Attention au risque de chronicisation
- Il y a toujours une relation entre la douleur chronique et les émotions

Éléments pouvant faciliter la prise en charge douloureuse chronique :

- Relation de confiance entre le patient et les soignants
- Prise en charge pluridisciplinaire, notamment psychologique
- Information des professionnels de santé

IX CONCLUSION.

- La relation est toujours facilitée lorsque le soignant montre clairement au patient qu'il croit à sa douleur et fait preuve d'empathie : il faut savoir expliquer que les causes sont diverses, qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, l'être humain est un tout
- Savoir être disponible pour écouter et créer le climat de confiance indispensable à une relation de qualité : prendre du temps